

药物相互作用简索表

合并用药对提高药物疗效,减少药物用量和不良反应,有十分重要的临床意义。但是有不少药物合用后,可以出现疗效降低或毒性增加。为了合理掌握药物的合并应用,笔者参考了部分有关文献,将国内临床上比较常用的一些药物合用后可能产生的药理学上的相互作用,列表加以简述,供读者参考。

主要作用于神经系统的药物

一、麻 醉 药

药 名	同 用 药 名	可 能 产 生 的 相 互 作 用
全身麻醉药	降压药及其他具有降低血压作用的药物(萝芙木生物碱;吩噻嗪类;单胺氧化酶抑制剂等)	降压作用增强
	卡那霉素;新霉素;链霉素	这类抗菌素如给全身麻醉患者腹腔注射,可引起神经肌肉麻痹及呼吸抑制反应
	盐酸羟嗪(安他乐)	产前或手术前用过安他乐时,麻醉药需要量应减半
	安定	可增强安定的作用
	琥珀酰胆碱	可致心动徐缓、窦性停跳、室上性和室性节律不整
乙 醚	心得安	心得安不应与抑制心肌的麻醉药如乙醚同时用于治疗心律不齐
	去甲肾上腺素	减弱滴注去甲肾上腺素时的加压反应
	速可眠	加重呼吸抑制
氯 仿	肾上腺素;去甲肾上腺素	氯仿能使心肌对这类药物敏感,同时用药能增加室性心动过速或心室纤颤的发生机会
	心得安	心得安不应与产生抑制心肌作用的麻醉药如氯仿同时用于治疗心律不齐

药 名	同 用 药 名	可 能 产 生 的 相 互 作 用
环丙烷、氟烷和甲氧氟烷	肾上腺素；去甲肾上腺素	环丙烷、氟烷和甲氧氟烷可使心肌对这类药物的作用敏感，同时用药可增加室性心动过速或心室纤颤的发生机会
	麦角衍生物和催产素	氟烷松弛子宫肌，使子宫对麦角衍生物和催产素不发生反应
局部麻醉药（包括卡波卡因）	中枢神经抑制剂；心血管抑制剂（如优降宁等）	与局部麻醉药一起用时，这些药物的作用有所增强
	血管收缩剂，催产剂	如临产时发生低血压（麻醉药可引起低血压），催产药与血管收缩剂合并应用可引起严重的持续性高血压
普鲁卡因	单胺氧化酶制剂	普鲁卡因作用可增强
	司可林	普鲁卡因静脉注射可增强司可林的作用
	对氨基水杨酸（PAS）	普鲁卡因可对抗对氨基水杨酸作用
	磺胺类药物	普鲁卡因水解生成对氨基甲酸，后者可对抗磺胺类抗菌作用

二、~~镇~~镇 静——催 眠 药

药 名	同 用 药 名	可 能 产 生 的 相 互 作 用
全部镇静、催眠药	中枢神经抑制药（醇；麻醉药；安定药；抗组织胺药；其它镇静、催眠药等）	镇静作用增强
	硫酸镁	加重镁盐的抑制效应
	优降宁	引起急性低血压和增强镇静作用
	口服降血糖药	镇静、催眠作用延长
巴比妥盐类	口服抗凝药	抗凝作用可因酶促作用而减弱；因此抗凝药的剂量需增大
	灰黄霉素	灰黄霉素的作用可因酶促作用而减弱
	抗组织胺药	抗组织胺作用因酶促作用而减弱
	苯妥英钠	可因苯巴比妥酶促作用而使苯妥英钠的作用减弱
	其他催眠药	镇静作用可能增强，但催眠药的代谢可因酶促作用而加速

药 名	同 用 药 名	可 能 产 生 的 相 互 作 用
巴比妥盐类	单胺氧化酶抑制剂	巴比妥盐类的作用可增强, 剂量应减少
	甾体激素	甾体激素的作用可因酶促作用而减弱
	吩噻嗪类镇吐药	加重巴比妥盐类中枢抑制作用
	解热镇痛药	增强解热镇痛药的镇痛作用
	胍苯噻嗪	引起病人极度困倦
水合氯醛	口服抗凝药	抗凝作用可因酶促作用而减弱
	单胺氧化酶抑制剂	水合氯醛的作用可增强, 剂量应减少
导眠能	口服抗凝药	抗凝作用可因酶促作用而减弱
安眠酮	可待因	增强可待因镇咳和镇痛作用
	利血平	增强安眠酮作用

三、 镇 惊 药

药 名	同 用 药 名	可 能 产 生 的 相 互 作 用
镇惊药	安 定	如以安定作为辅助药用于治疗各种惊厥疾患时, 必须增加基础镇惊药的剂量
	单胺氧化酶抑制剂	单胺氧化酶抑制剂对惊厥阈有程度不等的影响, 镇惊药的剂量应酌情改变
	吩噻嗪类; 萝芙木生物硷; 硫杂蒯类(如泰尔登)	这些药物可降低部分敏感患者的惊厥阈; 镇惊药的剂量必须增大
	三环抗抑郁药	大剂量的三环抗抑郁药可促使癫痫发作, 镇惊药的剂量应随之改变
巴比妥盐类镇惊药 (如苯巴比妥)	抗凝药	巴比妥盐类可引起酶促作用从而加速抗凝药的代谢
	吩噻嗪类	这类药物虽可强化巴比妥盐的抑制作用, 但镇惊作用并不因此增强
	相互之间	当二种巴比妥盐药物同时服用时, 各药的剂量应减为常用剂量的一半
苯妥英钠	对氨基水杨酸	如再与异菸肼(INH)合用, 则可抑制苯妥英钠的代谢

药 名	同 用 药 名	可 能 产 生 的 相 互 作 用
苯妥英钠	抗凝药	双香豆素可抑制苯妥英钠的代谢作用，使其作用增强；抗凝药的作用亦可增加
	皮质激素	苯妥英钠经酶促作用可促进皮质激素的代谢
	保泰松；磺胺苯吡唑	可抑制苯妥英钠的代谢而增强后者的作用
	利他林	利他林可提高苯妥英钠的血浓度
	水杨酸盐类	大剂量的阿司匹林可增强苯妥英钠的作用
硫酸镁（注射剂）	麻醉药和巴比妥盐类	增强镁的中枢抑制作用
	抗菌素（粘菌素、卡那霉素、新霉素、多粘菌素 B、链霉素、杆菌肽和万古霉素）	这些抗菌素可干扰神经肌肉接合部位的神经传递作用，加强硫酸镁的骨骼肌松弛作用
	肌肉松弛剂（如十烃季铵等）	镁离子减少运动神经末梢乙酰胆碱的释放量，加重神经肌肉阻断药的效果

四、镇 痛 药

药 名	同 用 药 名	可 能 产 生 的 相 互 作 用
扑热息痛	口服抗凝药	可增强抗凝药的作用
安乃近	氯丙嗪	不宜同时服用，因退热作用的增强可能导致严重的体温降低
	抗凝药	安乃近可加重凝血酶元的缺乏
消炎痛	口服抗凝药	抗凝作用可因蛋白结合部位被置换而增强
	羧苯磺胺（丙磺舒）	羧苯磺胺可干扰消炎痛的肾排泄；但羧苯磺胺的利尿尿酸尿的作用不受影响
	水杨酸盐类、保泰松、糖皮质激素类	消炎痛有可能增加这些药物的致溃疡作用
麻醉性镇痛药	口服抗凝药	长期服用麻醉性镇痛药可增强抗凝作用
	单胺氧化酶抑制剂	增强麻醉作用，同服时应减少剂量

药 名	同 用 药 名	可 能 产 生 的 相 互 作 用
麻醉性镇痛药	呼吸抑制药（麻醉药，巴比妥类，吩噻嗪类，镇静药，安眠药）	增强呼吸抑制作用，宜减少麻醉性镇痛药的剂量
羧基保泰松和保泰松	口服抗凝药	抗凝药物的效应可因蛋白结合部位被置换而增加
	强力化学治疗剂	毒性可能增加
	苯妥英钠	苯妥英钠可因其代谢作用被保泰松所抑制而增强
	降血糖药（胰岛素，磺酰脲类）	降血糖作用增强；保泰松和羧基保泰松可参与蛋白结合部位的置换作用
	水杨酸盐类	在治疗关节炎时，同时服二药有引起胃肠道溃疡的危险
	三环抗抑郁药	小白鼠试验表明，丙咪嗪可抑制保泰松在肠道的吸收
丙氧芬（达丰）	苏醒药（如苯丙胺，咖啡因苯甲酸钠）	丙氧芬的剂量不宜过多，否则可引起抽搐
水杨酸盐	尿道硷化剂	由于能加速水杨酸盐的排泄率而使其作用减弱
	抗凝药	剂量超过1克/天时，抗凝作用增强
	苯巴比妥	水杨酸盐的药效可因酶促作用而减弱
	羧苯磺胺（丙磺舒）	水杨酸盐拮抗丙磺舒的利尿尿酸尿作用
	长效磺胺类	水杨酸盐作用可因蛋白结合部位被置换而增强

五、安 定 药

药 名	同 用 药 名	可 能 产 生 的 相 互 作 用
所有安定药	中枢神经抑制药（醇，巴比妥盐类，麻醉药，镇静催眠药以及其它中枢神经抑制药）	中枢抑制作用增强；增强的程度取决于各个安定药
	单胺氧化酶抑制剂	单胺氧化酶抑制剂可增强安定药的作用；如与吩噻嗪合用有加强降压作用
利眠宁	口服抗凝药	抗凝作用会发生不同的改变
	吩噻嗪类	不宜合用

药 名	同 用 药 名	可 能 产 生 的 相 互 作 用
安 定	鎮惊药	安定如用作辅助药治疗惊厥疾患时，基础鎮惊药的剂量需增大
	吩噻嗪类	增强安定作用，不宜合用
	胃肠外输液	安定注射剂不宜加入输液中，亦不宜作进一步稀释
眠尔通，吩噻嗪类 (氯丙嗪、乙酰普 马嗪、奋乃静、异 丁嗪等)和硫杂蒽 类(泰尔登)	口服抗凝药	抗凝作用因酶促作用而减弱
	全身麻醉药	麻醉作用增强
	抗胆碱药(阿托品等)， 鎮惊药	抗胆碱作用增强；吩噻嗪和硫杂蒽可降低敏感患者的惊厥阈，鎮惊药的剂量需增大
	抗震颤麻痹药	吩噻嗪和硫杂蒽常合用于控制锥体外系症状
	安乃近	安乃近不宜与氯丙嗪合用；因退热作用的加强可能引起体温严重下降
	肾上腺素，阿拉明	肾上腺素和阿拉明不宜用于治疗吩噻嗪或硫杂蒽所引起的低血压，因这些药物可逆转肾上腺素或部分阻断阿拉明的作用导致血压进一步下降
	降压药(包括利尿药)	降压作用加强，可导致严重低血压或休克
	杀虫药(磷化合物)	杀虫药作用可增强
	戊四氮，印防己毒素	作为兴奋药，不宜应用过量，否则会引起惊厥
	三环抗抑郁药	三环抗抑郁药和吩噻嗪常合并用于治疗躁狂型抑郁症
	乙醇	抑制乙醇代谢，增强乙醇作用
	抗组织胺药	增强抗组织胺药鎮静和类阿托品作用
	奎尼丁	吩噻嗪类具有奎尼丁样作用，可导致室性心动过速
	麻醉性鎮痛药	麻醉性鎮痛药的鎮痛、鎮静和呼吸抑制作用增强，吩噻嗪类低血压反应加重；吩噻嗪类有的药物可对抗鎮痛药作用

六、中枢神经兴奋药

药名	同用药名	可能产生的相互作用
利他林	苯妥英钠	利他林可增加苯妥英钠的血浓度
	胍乙啶	可使胍乙啶的降压作用减弱
	单胺氧化酶抑制剂	合并用药必须谨慎
	升压药	升压作用增强
	三环抗抑郁药	利他林可影响丙咪嗪等的代谢
	巴比妥类	两药作用上对抗；同一针筒注射可发生沉淀
	安定药	两药作用上对抗
苯甲酸钠咖啡因	优降宁	可改变或加重咖啡因的治疗效应，应减少咖啡因用量
苯丙胺及其衍生物	尿液酸化剂	加速苯丙胺尿中排泄
	尿液硷化剂	苯丙胺活性可因排泄率下降而增强
	度冷丁	镇痛作用增强
	丙咪嗪	阻止苯丙胺肝中代谢，增加苯丙胺血中浓度和作用
	利血平	对用过利血平者无效
	胍乙啶	逆转胍乙啶降压作用，引起高血压危象
	甲基多巴	降压作用减弱
印防己毒素	戊巴比妥钠	戊巴比妥钠用于印防己毒素中毒剂量宜小

七、抗抑郁药

药名	同用药名	可能产生的相互作用
单胺氧化酶抑制剂：闷可乐；苯乙肼；优降宁；呋喃唑酮（痢特灵）	醇	可使醇的作用增强；应避免酒类饮料；如与呋喃唑酮并用可产生中毒反应
	苯丙胺及其衍生物	合并用药会引起高血压危象，故应避免同时服用

药 名	同 用 药 名	可 能 产 生 的 相 互 作 用
单胺氧化酶抑制剂： 闷可乐；苯乙肼； 优降宁；呋喃唑酮（痢特灵）	麻醉药	可增强麻醉药的麻醉和降压作用，单胺氧化酶抑制剂最好在手术前应停药，或减少麻醉药用量
	抗震颤麻痹药	同时服用会出现严重反应，因而要谨慎
	咖啡因	过量的咖啡因可引起高血压反应，故含咖啡因的药物应减量，含咖啡因的饮料亦应适当减少
	中枢神经抑制剂（巴比妥盐类，水合氯醛，镇静剂，催眠药，安定药等）	抑制作用可增强，抑制药的剂量应减少
	可卡因	可卡因的作用可增强
	麻黄碱及衍生物	避免同时服用，否则将会出现高血压危象或类似症状
	含有高浓度加压物质，例如含酪胺的食物（浓缩的或陈年的干酪、酒、腌青鱼、鸡肝、豌豆荚）	加压作用可增强，会出现高血压危象
	神经节阻断剂	由于优降宁可强化这些药物的作用，故不宜同时服用
	胍乙啶	可逆转胍乙啶作用，不宜同时服用或至少在单胺氧化酶抑制剂停药一周后才可应用胍乙啶
	降压药	作用增强，可出现低血压
	其他单胺氧化酶抑制剂	二种单胺氧化酶抑制剂不宜同时应用，建议在停用一种药物二周后再用另一种药治疗
三环抗抑郁药（如丙咪嗪）	萝芙木生物硷	单胺氧化酶抑制剂可抑制萝芙木生物硷从组织贮存部位所释放的色胺的破坏。故用优降宁治疗期间或其后的周内不宜注射利血平
	三环抗抑郁药	三环抗抑郁药不宜与单胺氧化酶抑制剂同时服用或在单胺氧化酶抑制剂停药至少二周后才可服用；二者合并用药可引起严重的阿托品样反应、震颤、惊厥和谵妄
	醇	醇和三环抗抑郁药的作用均可增强
	抗胆碱药，抗震颤麻痹药	由于三环抗抑郁药也具有轻度的抗胆碱活性，因而作用有所增强

药 名	同 用 药 名	可 能 产 生 的 相 互 作 用
三环抗抑郁药（如丙咪嗪）	度冷丁	可加重度冷丁的呼吸抑制作用
	苯巴比妥盐类及其他中枢神经抑制药	动物试验表明，三环抗抑郁药可增强巴比妥盐类的作用
	哌乙啶	可拮抗哌乙啶的降压作用
	降压药（例如噻嗪类利尿剂，吩噻嗪类，血管扩张药）	由于三环抗抑郁药可引起体位性低血压，故在与其他降压药物同时服用时应注意观察
	去甲肾上腺素	三环抗抑郁药可增加去甲肾上腺素的加压作用
	利血平	三环抗抑郁药可阻断或逆转利血平的抑制作用
泰尔登	抗组织胺药	加重抗组织胺药中枢抑制作用

八、拟交感神经兴奋药

药 名	同 用 药 名	可 能 产 生 的 相 互 作 用
拟交感神经兴奋药	单胺氧化酶抑制剂	合用时会出现严重高血压，不宜同服
	三环抗抑郁药	三环抗抑郁药和拟交感神经兴奋药的活性均增强
	黄嘌呤制剂	会出现中枢神经过度兴奋
肾上腺素	右旋甲状腺素	冠心病患者注射肾上腺素可促进冠状动脉机能不全；服用右旋甲状腺素的患者发生这种情况机会增多
	甲种受体阻断药（苯苄胺、苄咪唑、苄胺咪唑）	逆转肾上腺素作用，导致严重低血压
	乙种受体阻断药（心得安）	随心得安用后注入肾上腺素，通过压力感受器反射作用，可导致心率减慢
	神经节阻断药（美加明）	肾上腺素的血管作用加强
	普鲁卡因	普鲁卡因可引起循环衰竭，合用易致室性颤动
异丙肾上腺素	洋地黄	异丙肾上腺素禁用于由洋地黄中毒而引起心动过速的患者
	肾上腺素	这类药物不宜同时应用，因二者可对心脏有直接兴奋作用，合并应用会出现心律不齐，但可交替使用

药 名	同 用 药 名	可 能 产 生 的 相 互 作 用
异丙肾上腺素	其他拟交感神经兴奋药	其他药物的剂量应当减少, 以免引起过度反应
去甲肾上腺素	利尿药 (噻嗪类等)	可减弱去甲肾上腺素的动脉效应
	甲基多巴	去甲肾上腺素的作用增强
	萝芙木生物碱	可增加去甲肾上腺素的动脉效应
	全血、血浆或盐水	不宜放在一起作静脉输注
	抗心绞痛药 (硝酸酯类)	为去甲肾上腺素的生理对抗剂
	苄咪唑	逆转去甲肾上腺素作用, 导致血压下降
麻黄硷	异丙肾上腺素	同用应减量, 以防引起心血管症状
	呋喃唑酮, 优降宁等单胺氧化酶抑制剂	禁止合用, 以防血压过度升高
	胍乙啶	降压作用减弱
多巴胺	单胺氧化酶抑制剂	血压过度升高
	抗肾上腺素药	减弱多巴胺作用
阿拉明 (间羟胺)	单胺氧化酶抑制剂	血压过度升高
	甲基多巴	轻度增强阿拉明升压作用
	胍乙啶	升压作用减弱
	利血平	使阿拉明无效
甲苯丁胺 (恢压敏)	氯丙嗪	逆转恢压敏加压作用, 导致严重低血压
	单胺氧化酶抑制剂	血压过度升高
	胍乙啶	升压作用减弱
	利血平	使恢压敏无效
新福林	单胺氧化酶抑制剂	血压过度升高
	氟烷	可致严重心律不齐
	催产药	合用可导致严重持久的血压升高
甲氧胺	麦角生物硷	可致血压过度升高

九、拟副交感神经兴奋药

药 名	同 用 药 名	可 能 产 生 的 相 互 作 用
抗胆碱酯酶药 (阿苯铵(Ambenonium); 有机磷杀虫剂; 新斯的明; Pyridostigmine 等)	琥珀酰胆碱, 十烃季铵, 三碘季铵酚	抗胆碱酯酶药可增强这类药物的作用
	筒箭毒碱	拮抗筒箭毒碱的作用
	相互之间以及和其他拟副交感神经兴奋药	作用增强
新斯的明	抗胆碱药	抗胆碱药可延缓肠蠕动, 影响口服新斯的明的吸收
	卡那霉素; 新霉素; 链霉素	新斯的明可用于消除这些抗菌素所引起的呼吸抑制作用
毒扁豆碱	琥珀酰胆碱	使琥珀酰胆碱作用增强和延长
匹罗卡品	异氟磷	可减弱异氟磷作用

十、抗 肾 上 腺 素 药

药 名	同 用 药 名	可 能 产 生 的 相 互 作 用
苄胺咪唑(立其丁)	中枢抑制药(镇静催眠药、镇痛药、麻醉药)、胰岛素	立其丁试验前至少24小时应停用这类药物, 以防止假阳性反应
	抗高血压药	可阻止立其丁反应, 试验前至少二周即应停用抗高血压药
	强心甙	立其丁反应未完全消失前不宜应用强心甙

十一、抗 胆 碱 药

药 名	同 用 药 名	可 能 产 生 的 相 互 作 用
抗胆碱药	抗组织胺药, 吩噻嗪类; 三环抗抑郁药; 新斯的明	这些药物具有一定的抗胆碱活性, 因此可增强抗胆碱作用 抗胆碱药物可减慢肠蠕动而影响新斯的明口服制剂的吸收
阿托品	环丙烷	环丙烷麻醉下, 静注阿托品可引起严重和危险的心律不齐
	胆碱能药物	阿托品可妨碍胆碱能危象的早期识别

药 名	同 用 药 名	可 能 产 生 的 相 互 作 用
安坦,开马君	左旋多巴	合用于治疗震颤性麻痹症时各药剂量宜减小
优托品注射剂	苯巴比妥钠	有化学性配伍禁忌,不能在同一针筒中注射
氯磷定	吩噻嗪类、利血平、吗啡、茶硷、氨茶硷、琥珀酰胆硷	禁忌合用

十二、肌 肉 松 弛 药

药 名	同 用 药 名	可 能 产 生 的 相 互 作 用
抗震颤麻痹药	单胺氧化酶抑制剂	同时服用会出现严重反应,故必须谨慎
	吩噻嗪类,萝芙木生物碱,硫杂蒯类	与抗震颤麻痹药常合并用于控制锥体外系症状
司可林(琥珀酰胆硷),十烃季铵,三碘季铵酚(去极化肌肉松弛药)	抗菌素(粘菌素(抗敌素),卡那霉素,新霉素,多粘菌素 B,链霉素,双氢链霉素和杆菌肽(可能有作用))	这些抗菌素可干扰神经肌肉接合部位的神经传递作用,肌肉松弛药作用加强
	噻嗪类利尿药	通过排钾可加强肌肉松弛药作用
	普鲁卡因	静脉注射普鲁卡因可强化琥珀酰胆硷的作用
	奎尼丁	肌肉松弛作用增强
	(低温)	低温可增加药物敏感性
	硷性溶液	与硫贲妥钠等硷性溶液混合迅速破坏失效
	胆硷能药物	可加重琥珀酰胆硷等的作用
	筒箭毒硷	增加运动终极对筒箭毒硷的敏感性,筒箭毒硷剂量宜减小
	抗疟药	使假胆硷酯酶含量下降,延长琥珀酰胆硷等呼吸麻痹作用
	洋地黄	洋地黄化病人易引起心律不齐和停跳
筒箭毒碱(非去极化肌肉松弛药)	麻醉药(乙醚,环丙烧,氟烧,甲氧氟烧)	筒箭毒碱作用增强,剂量应减少

药 名	同 用 药 名	可 能 产 生 的 相 互 作 用
筒箭毒硷（非去极化肌肉松弛药）	抗菌素（粘菌素，卡那霉素，新霉素，多粘菌素乙，链霉素，双氢链霉素和杆菌肽（有可能））	这些抗菌素可干扰神经肌肉接合部位神经传递作用；可强化肌肉松弛药的作用
	抗胆碱酯酶药（新斯的明等） 利尿药（噻嗪类等）奎尼丁	这些药物可拮抗筒箭毒硷的作用 利尿药可增强筒箭毒硷的作用 筒箭毒硷作用可增强
	盐皮质激素	使钾丢失，增强筒箭毒硷作用
	硫酸镁	增强筒箭毒硷作用
左旋多巴（用于抗震颤麻痹症时）	单胺氧化酶抑制剂	左旋多巴开始用药前二周即应停用单胺氧化酶抑制剂
	向精神药物	合用时应注意特殊的不良反应
	维生素B ₆	维生素 B ₆ 10—25 毫克内服可迅速逆转左旋多巴的抗震颤麻痹效果

主要作用于内脏系统及影响组织代谢过程的药物

十三、降 压 药

药 名	同 用 药 名	可 能 产 生 的 相 互 作 用
全部降压药	利尿药（噻嗪类等） 其他降压药，吩噻嗪类， 单胺氧化酶抑制剂，三环 抗抑郁药，血管扩张药	这些药物也可引起血压下降，从而增强降压作用；故降压药物的剂量常须减少
胍乙啶	醇	醇可加重体位性低血压，这在用胍乙啶治疗时常可遇见
	麻醉药	手术前二周内不宜服用胍乙啶，以免在麻醉过程中可能发生血管性虚脱
	洋地黄	此二药均可减慢心率
	去甲肾上腺素	使去甲肾上腺素的效应增加；嗜铬细胞瘤患者不宜使用胍乙啶
	血管加压药	发生心律不齐的机会增多
	抗组织胺药（如 Pyribenzamine），吩噻嗪类（氯丙嗪）	可阻断胍乙啶作用
	神经节阻断药	开始用药前应先停用神经节阻断药，后者应逐渐减量到停用，以防血压突然升高

药 名	同 用 药 名	可 能 产 生 的 相 互 作 用
胍苯达嗪	肾上腺素	肾上腺素的升压效应减弱
	醇	醇麻醉作用增强
	神经节阻断药	胍苯达嗪用量宜减少一半，并注意观察
神经节阻断药（如美加明）	尿道酸化剂	美加明的作用可能因排泄率的增加而减弱
	尿道碱化剂	美加明的作用可能因排泄率的减慢而增大
	（过高热或剧烈运动）	降压作用增强
	泻药	便秘不宜用剧泻药
	抗菌药	用抗菌素或磺胺类治疗的肾盂肾炎病人禁用美加明
	利尿药，麻醉药，利血平	降压作用增强
甲基多巴	利尿药（如噻嗪类）	降压作用增强；利尿药还可对抗甲基多巴治疗中出现的体重增加和水肿
	单胺氧化酶抑制剂	可出现头痛、高血压以及类似症状，应避免合并用药
	三环抗抑郁药	降压作用减弱
	麻醉药	抑制手术时病人麻醉所造成的血压下降的机体代偿效应
优降宁（见抗郁药项下的单胺氧化酶抑制剂） 萝芙木生物碱（萝芙木蛇根碱，利血平，去甲氧利血平） 桂皮利血胺和 Syrosingopine	麻醉药	在手术前应停服萝芙木碱衍生物二周，以免麻醉时出现血压过低
	胍乙啶	同时服用可增加体位性低血压，心动过缓和精神抑郁
	心得安	由于附加的儿茶酚胺阻断作用可明显降低体内交感神经的活性
藜芦生物硷	洋地黄	病人如同时服用洋地黄极易发生心律不齐
	吗啡	藜芦硷的心搏徐缓作用与吗啡及有关药所产生的作用起相加作用
萝芙木生物硷	（电休克）	电休克前二周应停药，否则可导致严重甚或致死性反应
	（手术）	手术前二周应停药

十四、洋地黄甙

药名	同用药名	可能产生的相互作用
洋地黄甙	钙盐(注射给药)	钙浓度升高可使心脏对洋地黄甙的敏感性增大
	利尿药(噻嗪类, 速尿(腹安酸), 利尿酸等)	利尿药可引起低血钾症, 如失钾不予补充, 则心脏对洋地黄甙的作用更为敏感, 可能会出现洋地黄中毒
	异丙肾上腺素(喘息定)	异丙肾上腺素禁用于洋地黄中毒引起心动过速的患者
	皮质激素	皮质激素引起钾丢失, 易导致洋地黄中毒和心律不齐
	肝素钠	减弱抗凝效果
	普鲁卡因酰胺	用于严重洋地黄中毒时, 宜注意可以加重传导抑制和室性颤动
	奎尼丁	洋地黄中毒所致的心律不齐用奎尼丁危险
	琥珀酰胆碱	对洋地黄化病人可引起心律不齐或心跳停止

十五、抗心律不齐药

药名	同用药名	可能产生的相互作用
心得安	甲种受体阻断剂	在治疗嗜铬细胞瘤时为了避免血压激烈升高, 可一起使用
	降血糖药	可引起低血糖; 由于心得安妨碍急性低血糖的先兆体征和症状表现, 因此危险性就更大
	硝酸脱水山梨醇酯	曾报导, 在治疗心绞痛时有协同作用, 但二种药物合用是否有利尚有争论
	单胺氧化酶抑制剂	二者不宜同时应用或停药单胺氧化酶抑制剂二周后再用药
	异丙肾上腺素	能阻断异丙肾上腺素乙种受体兴奋作用
	去甲肾上腺素	可加重静脉滴注去甲肾上腺素引起的心脏指数的降低
奎尼丁	抗凝药	奎尼丁可抑制肝内凝血酶原的形式, 从而使抗凝作用增强

药 名	同 用 药 名	可 能 产 生 的 相 互 作 用
奎尼丁	萝芙木生物硷	出现心律不齐, 故合并用药必须谨慎
	藜芦生物硷	合用时必须谨慎, 并应注意观察
	吩噻嗪类	吩噻嗪类有奎尼丁样作用, 可致室性心动过速, 禁忌合用
利多卡因 (普罗卡因)	中枢抑制药, 心血管抑制药	利多卡因可加强这些药物的作用。
	优降宁	有人用优降宁后可减弱利多卡因麻醉作用
苯妥因钠 (大仑丁)	吗啡	用过吗啡的癫痫病人, 须待吗啡镇静作用减弱后再用大仑丁

十六、冠 状 血 管 扩 张 药

药 名	同 用 药 名	可 能 产 生 的 相 互 作 用
硝酸盐或酯	醇	醇可增敏这类药物的降压作用
	乙酰胆硷, 组织胺, 去甲肾上腺素	硝酸盐对这类药物有生理拮抗作用
	降压药	强力降压药应谨慎用药, 因如与硝酸盐合用可发生严重的低血压
潘生丁	洋地黄	有人认为潘生丁可增强洋地黄的作用, 但这种论点尚有疑问
	肝素	不宜合用, 潘生丁可抑制血小板粘附
罂粟硷	乳酸任氏液	二药混合可发生沉淀
氨茶硷	尿液酸化剂	加速氨茶硷排出
	有机磷杀虫药	禁用于有机磷杀虫药中毒

十七、降 血 脂 药

药 名	同 用 药 名	可 能 产 生 的 相 互 作 用
安妥明	口服抗凝药	抗凝药的效应增加, 开始用安妥明治疗时, 抗凝药的剂量应减少 $\frac{1}{2}$ 至 $\frac{1}{3}$
	磺酰脲	在用安妥明治疗糖尿病时应细心观察。在服甲苯磺丁脲的患者中, 曾有降血糖作用增强的情况

药 名	同 用 药 名	可 能 产 生 的 相 互 作 用
右旋甲状腺素	口服抗凝药	抗凝药作用增强，可能由于对受体部位的亲和性增大所致；开始用右旋甲状腺素治疗时抗凝药的剂量应当减少 $\frac{1}{2}$ ，随后酌量调整
	降血糖药	右旋甲状腺素可增加血糖量，故降血糖药的剂量应增大
	甲状腺制剂	其他甲状腺制剂的剂量可酌情改变

十八、利 尿 药

药 名	同 用 药 名	可 能 产 生 的 相 互 作 用
噻嗪类及氯噻酮，利尿酸，速尿	醇	可能引起体位性低血压
	巴比妥盐类	可引起体位性低血压
	麻醉药	可引起体位性低血压
	皮质激素 促肾上腺皮质激素	由于这类药物和利尿药都可引起低血钾，故可使钾大量丢失
	降压药	降压作用增强；利尿药常可减少降压药的用量
	单胺氧化酶抑制剂	可发生低血压
	氯化铵	对肝功能不全患者不宜用氯化铵来纠正利尿药所引起的低氯性硷中毒
	钾盐	钾盐常用来纠正利尿药引起的低血钾；应尽可能避免用肠溶衣钾盐，否则会发生小肠溃疡
	吩噻嗪	可致严重低血压和休克
	阿斯匹林	均能升高血中尿酸，合用有的病人可引起急性痛风
汞利尿剂	氯化铵	汞利尿剂可引起低氯性硷中毒，而使利尿药的效果减弱；服用氯化铵可恢复汞利尿剂的效应
	镇痛药（如美散痛）	有时可影响肾功能，减少尿量，阻断汞利尿剂作用的发挥
	皮质激素（甲基强的松龙）	增强利尿作用，恢复顽固心病性水肿病人对汞利尿剂的效应
螺旋内酯和氨苯喋啶	其它利尿剂	螺旋内酯和氨苯喋啶常常与其他类利尿药合用以减少钾丢失和增强作用

药 名	同 用 药 名	可 能 产 生 的 相 互 作 用
螺旋内脂和氨苯喋啶	降压药	降压作用增强
	相互之间	可发生高血压
碳酸酐酶抑制剂	相互之间	可发生高血钾
右旋糖酐	(血型测定)	可引起红细胞假凝集反应
全部利尿药	碳酸锂	碳酸锂减少肾小管对钠重吸收, 并引起腹泻和出汗, 不宜与利尿药合用

十九、 利 尿 酸 尿 药

药 名	同 用 药 名	可 能 产 生 的 相 互 作 用
利尿酸尿药	利尿药如噻嗪类等	利尿药可降低尿酸的肾排泄, 故尿酸尿药的剂量需加大
羧苯磺胺	尿道硷化剂	酸性尿易析出尿酸盐结晶; 硷化小便可减少尿酸结石的形成
	消炎痛	羧苯磺胺干扰消炎痛的肾排泄, 但羧苯磺胺的利尿酸尿作用不被阻断
	碳酸氢钠, 枸橼酸钾	尿酸盐在酸性尿中可析出结晶, 应多喝水, 并加服足量碳酸氢钠或枸橼酸钾, 使尿呈硷性

二十、 抗 组 织 胺 药

药 名	同 用 药 名	可 能 产 生 的 相 互 作 用
抗组织胺药	口服抗凝药	抗组织胺药可减弱抗凝药的作用
	中枢神经抑制药(醇、镇静药, 催眠药, 麻醉药, 安定药等)	镇静作用增强
	单胺氧化酶抑制剂	由于单胺氧化酶抑制剂可抑制抗组织胺药的代谢, 而使作用增强
	安络血	能抑制安络血效果, 用安络血前48小时应停用抗组织胺药。如时间不许可, 应加大安络血用量
	肝素钠	减弱肝素钠的效果
苯海拉明	巴比妥盐类	苯海拉明以及其他抗组织胺药均可引起酶促作用而使巴比妥盐类的活性减弱, 但镇静作用在开始时却增强

药 名	同 用 药 名	可 能 产 生 的 相 互 作 用
苯海拉明	皮质激素（以及其他能被肝微粒体酶代谢的药物）	因酶促作用使皮质激素效应减弱
	卡那霉素；新霉素；链霉素	茶苯海明可掩盖这些抗菌素引起的耳中毒症状
吩噻嗪类抗组织胺药——见安定药项下吩噻嗪类		

二十一、抗 贫 血 药

药 名	同 用 药 名	可 能 产 生 的 相 互 作 用
铁盐	抗坏血酸	曾主张用大剂量的抗坏血酸来增进口服铁剂的吸收
	青霉素	可致铁缺乏，尤其是对经期妇女或儿童
	新霉素	每日服4—6克可阻碍铁的吸收
维生素B ₁₂	维生素C	片剂溶于含维生素C溶液中易破坏。

二十二、止 血 药 和 抗 凝 药

药 名	同 用 药 名	可 能 产 生 的 相 互 作 用
口服抗凝药	乙醇	可能改变抗凝药的作用，但未能断定
	麻醉药	可增强抗凝作用
	抗菌素（氯霉素，新霉素，四环素，青霉素）	可使抗凝药作用增强，部分原因是由于胃肠道维生素K的生物合成受到干扰所致
	利他林	抗凝药的作用因代谢受抑制而增强
	去胆固醇树脂	抗凝作用可因抑制或延迟吸收而减弱；但维生素K的吸收也同时减弱。故建议抗凝药至少在服去胆固醇树脂前一小时应用
	皮质激素，促肾上腺皮质激素	可改变抗凝药的反应
	苯妥英钠	由于抗凝药从蛋白质结合部位被置换而使其作用增强；抗凝药能增加苯妥英钠的血清浓度而导致苯妥英钠的中毒

药 名	同 用 药 名	可 能 产 生 的 相 互 作 用
口服抗凝药	甲基或丙基硫氧嘧啶	可增强抗凝药的作用
	甲苯磺丁脲, 氯磺丙脲	甲苯磺丁脲和氯磺丙脲的降血糖作用可因代谢受抑制而增强
	安乃近	加重凝血酶原的缺乏
	扑湿痛 (Mefenamic acid)	加重抗凝药降低凝血酶原的作用
	安他乐	合用宜慎重, 抗凝药用量宜减
	同化类固醇类	加强抗凝药作用, 抗凝药用量须调整
	先锋霉素 2 号	先锋霉素 2 号可延长凝血酶原时间
	光神霉素	光神霉素减少凝血酶原含量, 延长凝血和出血时间, 不宜与抗凝药合用
维生素 K	抗凝药	大剂量维生素 K 可拮抗抗凝药的作用
	稀释剂	不宜采用 0.9 % 氯化钠和 5 % 葡萄糖盐水以外的溶液稀释
肝素	口服抗凝药	抗凝作用增强
	多粘菌素 B	静脉给药两药不宜混合在一起
	四环素	可减弱肝素临床效果

二十三、支 气 管 扩 张 药

药 名	同 用 药 名	可 能 产 生 的 相 互 作 用
黄嘌呤制剂 (胆茶碱等)	口服抗凝药	大剂量黄嘌呤衍生物可改变抗凝药的作用
	其它黄嘌呤制剂, 拟交感神经兴奋药	可发生明显的中枢神经兴奋作用

二十四、制 酸 药

药 名	同 用 药 名	可 能 产 生 的 相 互 作 用
制酸药	酸性药物 (呋喃妥因, 磺胺等)	因制酸药提高 PH, 使胃肠道对弱酸的吸收减少
	口服抗凝药	大剂量的制酸药可抑制抗凝药的吸收, 而使其作用减弱
	碱性药 (如苯丙胺, 度冷丁)	因制酸药制提高 PH 使胃肠对弱碱的吸收增多

药 名	同 用 药 名	可 能 产 生 的 相 互 作 用
制酸药	四环素类	制酸药的阳离子与四环素可形成难吸收的络合物
	凝血酶	影响凝血酶的活性

二十五、 泻 药

药 名	同 用 药 名	可 能 产 生 的 相 互 作 用
矿物油	口服抗凝药	在少数情况下发现抗凝药的作用有不同的改变
	维生素类	长期服用矿物油可减少脂溶性维生素A、D、E、K的吸收

二十六、 激 素

雄 性 激 素

药 名	同 用 药 名	可 能 产 生 的 相 互 作 用
甲基雄稀醇酮 (Dianabol)	口服抗凝药	抗凝作用增强
	羟基保泰松	可使羟基保泰松的血浆浓度增高
去甲乙基睾酮; 睾丸素	口服抗凝药	抗凝作用增强
	苯巴比妥	睾丸素可因酶促作用而减弱

皮 质 激 素

药 名	同 用 药 名	可 能 产 生 的 相 互 作 用
皮质激素及促皮质激素	制酸药	皮质激素可引起胃酸过多或消化性溃疡, 如长期应用皮质激素应以制酸药预防
	抗结核药	皮质激素常禁用于结核病患者, 但在某些病例, 如与抗结核药合用时可挽救生命
	巴比妥盐类	皮质激素的作用可因酶促作用而减弱
	降血糖药	皮质激素可提高血糖浓度; 降血糖药的剂量需增大
	水杨酸盐类, 消炎痛, 扑湿痛	合用于治疗关节炎患者时必须谨慎, 有增加胃肠道溃疡的危险

药 名	同 用 药 名	可 能 产 生 的 相 互 作 用
皮质激素及促皮质素	全身麻醉药	用过激素者常规麻醉可致严重低血压和循环衰竭
	水合氯醛	不宜合用
	血管加压药	可合用于治疗对其他措施无反应的休克
	疫苗	激素可抑制机体抵抗力, 不宜合用
醋酸甲基强的松龙	其他药液	不宜与其他溶液混合或稀释
螺旋内酯	稀释液	不宜采用含有酚等防腐剂的稀释液

雌 性 激 素

药 名	同 用 药 名	可 能 产 生 的 相 互 作 用
雌激素和孕激素合剂(口服避孕药)	抗凝药	口服避孕药有维生素K样作用, 可减弱抗凝药的作用, 抗凝药的剂量需增大
	降血糖药	可提高血糖浓度; 降血糖药的剂量需增大

甲 状 腺 激 素

药 名	同 用 药 名	可 能 产 生 的 相 互 作 用
甲状腺制剂	右旋甲状腺素	甲状腺制剂的剂量宜加调整
	三环抗抑郁药	三环抗抑郁药和甲状腺效应均可增强

降 血 糖 药

药 名	同 用 药 名	可 能 产 生 的 相 互 作 用
胰岛素, 降糖灵, 磺酰脲类(氯磺丙脲, 甲苯磺丁脲)	皮质激素; 右旋甲状腺素; 利尿药(噻嗪类, 氯噻酮, 利尿酸, 速尿), 雌激素, 菸酸(大剂量) 口服避孕药	这些药物均可提高血糖浓度, 降血糖药的剂量需增大
	醇	反应不能预测, 曾报导, 在与磺酰脲合用时出现双硫醒样反应; 报导指出, 嗜酒患者的甲苯磺丁脲代谢增加可能与酒量有关, 而与是否是慢性嗜酒无关
	单胺氧化酶抑制剂	降血糖作用增强

药 名	同 用 药 名	可 能 产 生 的 相 互 作 用
胰岛素,降糖灵, 磺酰脲类(……)	吩噻嗪类	合用有可能引起黄疸及肝功能异常
磺酰脲	口服抗凝药	已证实,香豆素抗凝药可抑制磺酰脲的代谢,而增强降血糖作用
	巴比妥盐类(及其它镇静药和催眠药)	磺酰脲可延长这些中枢神经抑制药的作用
	胰岛素	降血糖作用增强
	降糖灵	降血糖作用增强
	羧苯磺胺	降血糖效应增强;但也有报导指出羧苯磺胺对甲苯磺丁脲的代谢影响很小
	水杨酸盐	降血糖效应增加,部分原因由于蛋白结合部位被置换所致
	磺胺类	降血糖效应可能由于蛋白结合部位被置换而增强;多数肯定的资料是研究磺胺苯吡唑和甲苯磺丁脲的应用问题

二十七、 作 用 子 宫 药

药 名	同 用 药 名	可 能 产 生 的 相 互 作 用
催产药(催产素、 麦角新碱)	升压药	可引起过度的血压升高

二十八、 维 生 素 类

药 名	同 用 药 名	可 能 产 生 的 相 互 作 用
对氨基苯甲酸	金治疗剂	与金制剂合用治疗关节炎可引起皮炎和/或发热的机会增多
脂溶性维生素 (A、D、E、K)	去胆固醇树脂	可影响这类维生素的吸收
	矿物油	长期服用矿物油可妨碍这些维生素的吸收
维生素 C	抗凝药	维生素 C 缺乏可增强抗凝作用
维生素 D	植酸钠	可增加钙的吸收

抗微生物、抗寄生虫病药物及抗癌肿药物

二十九、抗 感 染 药

驱 虫 药

药 名	同 用 药 名	可 能 产 生 的 相 互 作 用
派啉（驱蛔灵）	吩噻嗪类	同用可能增大锥体外系的反应
四氧乙稀	醇	四氧乙稀可引起酪酐症状，醇可增强这种反应，所以在用药前后24小时内不宜饮酒
噻苯咪唑	（糖尿病患者慎用）	此药偶可引起多血糖症

抗 菌 素

药 名	同 用 药 名	可 能 产 生 的 相 互 作 用
二性霉素乙	抗菌素；抗代谢物；皮质激素；氮芥	用过这些药物的患者有时会出现深部真菌感染；除非为了控制二性霉素乙的反应或必须用于治疗原发疾病，否则这些药物不宜与二性霉素乙同时应用
氯霉素	青霉素	氯霉素为抑菌剂而青霉素为杀菌剂；由于青霉素仅对增殖性细菌有效，故氯霉素有可能抑制其抗菌作用
	其他抑制骨髓药物	应避免同时应用
	苯巴比妥	动物试验表明，先以苯巴比妥治疗会降低氯霉素的血浓度及其化疗活性
粘菌素和多粘菌素乙	卡那霉素，新霉素，链霉素，双氢链霉素	这些药物可干扰神经肌肉接合部位的神经传递；由于粘菌素和多粘菌素乙也能引起这种反应，故不宜合用以防导致肌无力和呼吸暂停
红霉素	尿道碱化剂	红霉素抗菌活性随着尿的 PH 变为碱性而增强
	林可霉素	体外试验证明红霉素和林可霉素间有拮抗作用
	羧苯磺胺	动物试验证实羧苯磺胺抑制红霉素在肾小管的再吸收
灰黄霉素	口服抗凝药	灰黄霉素可引起酶促作用，使抗凝药的代谢加速，因此抗凝药的剂量必须增大

药 名	同 用 药 名	可 能 产 生 的 相 互 作 用
灰黄霉素	巴比妥盐类	已证实苯巴比妥可引起酶促作用而使灰黄霉素的作用减弱
卡那霉素, 新霉素, 链霉素, 庆大霉素	麻醉药; 肌肉松弛药	这些抗菌素与麻醉药或肌肉松弛药同时腹腔注射时, 可发生神经肌肉麻痹和呼吸抑制; 因此患者在用麻醉药或肌肉松弛药尚未完全苏醒前不宜用这些抗菌素
	尿道碱化剂	碱性尿可增强尿道的抗菌活性; 但仅在用链霉素和庆大霉素治疗尿道感染时, 才需要碱化尿液
	茶苯海明, 晕海宁	晕海宁可掩盖这些抗菌素引起的耳中毒症状
	相互之间	这些药物在同时或顺序给药时可能发生累积性耳中毒症状
林可霉素	红霉素	体外试验表明, 红霉素和林可霉素间有拮抗作用
青霉素类	抑菌性抗菌素(氯霉素, 磺胺类, 四环素等)	青霉素为杀菌药, 但仅对繁殖性细菌有效, 抑菌性抗菌素可抑制青霉素类抗菌素的抗菌作用
	红霉素	低浓度红霉素抑菌而对抗青霉素作用, 高浓度杀菌而增强青霉素作用
	羧苄磺胺	由于羧苄磺胺能干扰青霉素G的肾小管排泄和减少其分布容积, 故可增强青霉素类的作用
四环素	抗凝药	抗凝药的作用增强; 其作用的发挥部分是由于干扰了胃肠道内维生素K的生物合成所致
	阳离子(二价和三价化合物例如 Ca^{++} , Mg^{++} 及 Al^{+++}) 制酸剂 牛奶	这些阳离子在胃肠道内可与四环素形成难于吸收的络合物; 但应指出, 同时给予牛奶, 对强力霉素的吸收并无显著影响
	肝脏毒性药物	已知四环素可引起肝脏损害; 如静脉注射四环素时, 其他可能的肝脏毒性药物应尽量避免合用
二性霉素乙	稀释液	稀释液中含制菌药(如苯甲醇)时可产生沉淀, 仅能以 $\text{PH}4.2$ 以上的5%葡萄糖液稀释
庆大霉素	多粘菌素类、先锋霉素2号	对肾脏毒性增加
新青霉素I	卡那霉素	不能混合, 否则均失效

药 名	同 用 药 名	可 能 产 生 的 相 互 作 用
先锋霉素 1 号	酸性或硷性溶液	先锋霉素 1 号不宜加入低于 PH 4 或高于 PH 7 的溶液
	羧苯磺胺	可阻止先锋霉素 1 号从肾小管排泄
先锋霉素 2 号	抗凝药	可延长凝血酶原时间

抗 疟 药

药 名	同 用 药 名	可 能 产 生 的 相 互 作 用
氯喹	肝脏毒性药物	已知氯喹浓集于肝脏，如在应用肝脏有毒性药物时，给药必须谨慎
	保泰松	保泰松以及其他可引起过敏和皮炎的药物都不宜与氯喹合用
	氯化铵	尿液酸化后可大大增加氯喹排泄
伯氨喹	阿的平	不宜同时服用伯氨喹与阿的平，对最近服过阿的平的患者，也不宜给予伯氨喹，否则毒性将会增大
	氯喹	易出现不良反应
奎宁	抗凝药	奎宁能抑制肝内凝血酶原的形成，故抗凝药的作用增强
阿的平	氯化铵	尿液酸化后可大大增加阿的平排泄
	保泰松、金化合物	可致过敏和皮炎，不宜与阿的平合用
乙胺嘧啶	磺胺类	有协同作用

抗 结 核 药

药 名	同 用 药 名	可 能 产 生 的 相 互 作 用
抗结核药	相互之间	几种抗结核药合用，可提高治疗效果，减少细菌的耐药性
对氨基水杨酸	羧苯磺胺	羧苯磺胺可减少对氨基水杨酸的尿排泄从而提高其血浆浓度
	水杨酸盐类	水杨酸盐中毒的危险性增大
	肝素	影响凝血酶原值，增加出血倾向

药 名	同 用 药 名	可 能 产 生 的 相 互 作 用
异菸肼	对氨基水杨酸	对氨基水杨酸可增加和延长异菸肼的血液浓度
	苯妥英钠	苯妥英钠的作用可因代谢受抑而增强
	度冷丁	某些病人可出现严重甚至致死性反应（如昏迷、低血压等）
	拟肾上腺素能药	可加重异菸肼不良反应
环丝氨酸	醇	使环丝氨酸引起惊厥的危险性增加
乙硫异烟胺 (1314th)	其他药物	可加重其他药物的不良反应

抗 病 毒 药

药 名	同 用 药 名	可 能 产 生 的 相 互 作 用
金刚烷胺	中枢神经兴奋药，向精神药物	由于金刚烷胺有中枢神经和精神方面的付作用，故这些药物合用时必须审慎

磺 胺 类 药 物

药 名	同 用 药 名	可 能 产 生 的 相 互 作 用
磺胺类	尿道碱化剂	应用某些老的磺胺药（如磺胺嘧啶等）时需要硷化小便以防结晶尿发生，由于磺胺是弱酸性，硷化尿可增加磺胺药的排泄率，同时药物的作用也可能降低
	对氨基苯甲酸（PABA）	磺胺为有效的抗菌药，可与PABA竞争并阻止微生物对PABA的正常利用；如PABA浓度增高，则磺胺的活性下降。某些具有PABA母核的局部麻醉药可能都有相同的作用
	制酸药	减少磺胺在胃肠道的吸收
	口服抗凝药	抗凝药作用的增强，部分原因可能是由于蛋白结合部位被置换以及胃肠道内维生素K的生物合成受到干扰所致
	苯妥英钠	曾报导，磺胺苯吡唑可抑制苯妥英钠的代谢，而使后者作用增强

药 名	同 用 药 名	可 能 产 生 的 相 互 作 用
磺胺类	青霉素	磺胺为抑菌药而青霉素为杀菌药，青霉素仅对繁殖性细菌有效，因此磺胺可抑制青霉素的抗菌作用
	羟基保泰松，保泰松和水杨酸盐	磺胺类的活性可因蛋白结合部位被置换而增加
	羧苯磺胺	羧苯磺胺可增加血浆中总磺胺浓度
琥珀酰磺胺噻唑，酞磺胺噻唑	矿物油	妨碍这些磺胺药的吸收
磺胺醋酰钠	银制剂，链霉素钙盐	不宜混合

其 它 抗 炎 剂

药 名	同 用 药 名	可 能 产 生 的 相 互 作 用
呋喃唑酮一抗抑郁药项下的单胺氧化酶抑制剂		
乌洛托品	尿道硷化剂	乌洛托品释放甲醛及生效需要酸性尿的条件；硷化小便可降低其作用
	磺胺类	磺胺类在乌洛托品生效的酸性尿中不易溶解；如与某些磺胺合用时可发生结晶尿
灭滴灵（硝基羟乙唑）	醇	曾报导，饮酒后易出现头痛和胃肠道反应

三十、抗 肿 瘤 药

药 名	同 用 药 名	可 能 产 生 的 相 互 作 用
抗肿瘤药（包括氟脲嘧啶，光神霉素等）	其他抑制骨髓药物	可使骨髓严重抑制，有些抗肿瘤药物可合并应用，但也有些抗肿瘤药物禁忌合用
硫唑嘌呤	别嘌呤醇（Allopurinol）	别嘌呤醇抑制硫唑嘌呤的代谢，因此后者剂量宜比正常用量减少 $\frac{1}{2}$ 至 $\frac{1}{4}$
长春花硷	谷氨酸	动物试验证明，谷氨酸和色氨酸可逆转长春花硷的抗肿瘤作用
环磷酰胺	氯霉素	动物试验表明，先用氯霉素治疗可减少环磷酰胺的致死率，这种作用显然是由于在体内使环磷酰胺活化的微粒体酶受抑制之故
	皮质激素	动物试验表明，环磷酰胺的活化作用可被去氢氢化可的松抑制

药 名	同 用 药 名	可 能 产 生 的 相 互 作 用
放线菌素D	青霉素G	体外试验表明, 青霉素G的杀菌作用可被拮抗
巯基嘌呤	别嘌呤醇	别嘌呤醇抑制巯基嘌呤的代谢, 因此后者的剂量要比正常用量减少 $\frac{1}{3}$ 至 $\frac{1}{4}$
甲氨喋呤	对氨基苯甲酸, 水杨酸盐, 磺胺药(抗菌类, 利尿类或降血糖类)	这些药物可置换白蛋白结合部位上的甲氨喋呤而使其毒性增大
	甲酰四氢叶酸	可对抗甲氨喋呤的作用, 过量时可用作解毒剂
噻替哌 (Thio-TEPA)	氯霉素 磺胺类	可加重骨髓的抑制作用

三十一、 消 毒 剂

药 名	同 用 药 名	可 能 产 生 的 相 互 作 用
季铵类防腐剂	阴离子药物, 肥皂	阴离子药物和肥皂均与阳离子季铵盐化合物禁忌配伍

三十二、 酶 类 制 剂

药 名	同 用 药 名	可 能 产 生 的 相 互 作 用
菠萝蛋白酶	抗凝药	抗凝作用增强
糜蛋白酶—胰蛋白酶	抗凝药	合并应用时必须注意观察
链激酶—链道酶	抗菌素	肌肉注射链激酶时应伴以一种广谱抗菌素
	抗凝药	血凝障碍或肝功能不良者, 不宜肌肉注射该酶制剂

三十三、 其 他

药 名	同 用 药 名	可 能 产 生 的 相 互 作 用
别嘌呤醇	铁盐	动物试验报导, 合并用药可增高肝铁浓度, 故应避免合用
	利尿酸尿药	合并用药对巯基嘌呤的尿排泄量要比别嘌呤醇单独服用时的排泄为少; 但是合并用药可保证许多患者收到良好的控制效果

药 名	同 用 药 名	可 能 产 生 的 相 互 作 用
谷氨酰精氨酸	其他药物	许多药物包括巴比妥、异菸肼、麻醉药以及利尿药等均可产生氨或干扰谷氨酰精氨酸的排泄
去胆固醇树脂	其他药物	去胆固醇树脂在胃肠道内可与其他药物结合而影响其吸收；去胆固醇树脂对酸性药物有很大的亲和性，并有轻度的吸收中性和硷性药物的作用，因此去胆固醇树脂和其他药物的给药间隔期应尽量延长
	钙	可增加钙的吸收
二巯基丙醇 (BAL)	铁剂	可形成有毒化合物，不宜用于服铁剂过量的病人
秋水仙硷	中枢神经抑制药	动物试验表明，秋水仙硷可因抑制药而增敏
	拟交感神经兴奋药	动物试验表明，可增强秋水仙硷作用
	维生素 B ₁₂	可干扰 B ₁₂ 在胃肠道的吸收

参 考 文 献

- 1.上海市医学科学情报站编，药物相互作用汇集表，医学情况交流 1973年11月。
- 2.G. Swidler, Hamdbook of Drug Interactions, 1971.
- 3.H. F. Morelli et al, Calif. Med, 109 : 380—389(Nov. 1968).
- 4.Drug Interactions, Med. Sci, 27—28 (May 1967)

(介 行)